Processo nº 0015244-58.2025.8.17.2001

AUTOR(A): L. O. B.
REPRESENTANTE: FLAVIA MARIELLI ALVES OTTOBONI BERNARDO

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS** ajuizada por **L.O.B.**, menor impúbere (ID 195517806), neste ato representado por sua genitora **FLAVIA MARIELLI ALVES OTTOBONI BERNARDO,** e através de advogado constituído (ID 195517803), em face da **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, objetivando o fornecimento da "*medicação Diacomit 250 mg em quantidade de 240 sachês iniciais e acréscimos de dosagens mediante novas prescrições médicas enquanto durar o tratamento*", para fins de tratar Síndrome de Dravet, conforme laudo e receituário médicos (IDs 195517810 e 195517811).

À saída, a parte autora requer: **(1)** o benefício da justiça gratuita; **(2)** a concessão de tutela de urgência; e **(3)** prioridade de tramitação, nos termos do parágrafo único, do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990). Ademais, informa que não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação (art. 19, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015).

Consta na inicial que o demandante é menor, com 7 anos de idade (ID 195517806), beneficiário de plano de saúde individual/familiar da ré, conforme carteira do plano de saúde (ID 195517807), diagnosticado com Transtorno do espectro autista – TEA (CID10-F84.0), associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID10-F90.0), e a Síndrome de Dravet (CID10-G40), cujos tratamentos iniciais com medicamentos comuns não surtem tanto efeito, uma vez que trata-se de crise epilética grave e progressiva, conforme laudo de ID 195517810.

Afirma que esta condição traz ao autor prejuízos na atenção seletiva, processamento temporal, inabilidade com aspectos de comunicação, dificuldade de integrar informações auditivas a outras mobilidades, processamento temporal, estando fortemente interligada a sua condição de TEA, que somados agravam as sequelas e a vida cotidiana do autor de modo geral.

Assevera que tal quadro pode ter uma evolução SIGNIFICATIVA se alinhado com terapias já aprovadas e efetivas, reconhecidas pela medicina como um todo, inclusive já aplicadas há anos em pessoas com condições semelhantes.

Declara que o menor teve seu diagnóstico sido concluído a um bom tempo, sendo-lhe prescrito pelo neurologista pediátrico uma série de terapias multidisciplinares de modo ininterrupto, como psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, com acompanhamento médico nas especificidades de neurologia e psiquiatria, além de vigilância constante de terceiros nas realizações de suas atividades, devido as suas limitações intelectuais e cotidianas e medicação bem específica que aqui é pedida, qual seja**, Diacomit 250 mg**, conforme laudo e receituário médicos de IDs 195517810 e 195517811.

Informa que solicitou a medicação prescrita à operadora de planos de saúde demandada, ao que adveio a negativa da Unimed Recife, sob a "*justificativa de Impossibilidade de autorização da medicação Diacomit 250 mg* ***por ausência de cobertura Contratual*****"** (ID 195517812), estando o menor sem o devido tratamento receitado e com grandes sequelas para sua vida normal.

Dado ao narrado, a parte autora propõe a presente ação. Pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência para compelir a ré a "*fornecer o custeio do tratamento*", "*com o deferimento do custeio de <u>medicação Diacomit 250 mg em quantidade de 240 sachês iniciais e acréscimos de dosagens mediante novas prescrições médicas enquanto durar o tratamento</u>. Ante prescrição legal do médico que acompanha o autor*". Tudo nos termos do laudo e receituário médicos (IDs 195517810 e 195517811).

No mérito, além da confirmação da tutela, requer a condenação da ré a pagar: **(a)** indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, sendo este o valor atribuído à causa; e **(b)** honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Decisão interlocutória de ID 195651725: (i) defere a gratuidade judiciária a parte autora; (ii) concede a prioridade na tramitação do feito; (iii) determina emenda à inicial para juntar procuração em favor do advogado que assinou a petição inicial, subscrita pela mãe do menor, outorgando poderes em nome da criança; (iv) reserva-se para apreciar o pedido de tutela de urgência em outro momento processual, após a formação do contraditório.

A ré, **Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico,** apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, argumentou pela inexistência de obrigação contratual para fornecimento do medicamento Diacomit, destacando que: (i) o medicamento não possui registro na ANVISA; (ii) trata-se de

medicamento de uso domiciliar, excluído da cobertura obrigatória pelo art. 10, VI da Lei 9.656/98; (iii) ausência de urgência/emergência comprovada; (iv) inexistência de danos morais. Requereu perícia judicial e a total improcedência da ação.

Réplica apresentada pela parte autora no ID 202543475, sem pugnar por provas, indicando, ademais a desnecessidade da prova pericial solicitada pela operadora de saúde.

A Unimed Recife, por seu turno, requereu a produção de perícia técnica, para identificar se o tratamento com o fármaco prescrito é realmente necessário (ID 203265382).

O **Ministério Público** se manifestou favoravelmente a procedência do pedido, com a concessão da tutela de urgência, para que a ré seja compelida a custear a medicação Diacomit 250 mg, na forma requerida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a analisar e decidir.

Verifico que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art.355, I, do CPC/2015.

De início, merece registro que o medicamento ora solicitado é ministrado fora do regime de internação hospitalar. Assim, a questão fulcral para apreciação reside em identificar se o fornecimento de medicamento para uso domiciliar – Diacomit - é ou não serviço de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, de conformidade com a legislação de regência. Neste contexto, não se mostra necessário a produção da **prova técnica pericial** solicitada pela operadora de saúde, que **resta indeferida**.

Pois bem. Tratando-se de medicamentos ministrados fora do regime de internação hospitalar ou ambulatorial, não versando sobre tratamento de neoplasia, a exclusão de cobertura encontra suporte no art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigência mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**:
>
> **(…)**
>
> VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Para além disto, preconiza a Resolução Normativa 465/2021 da ANS:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar**, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Neste ser assim, há cobertura para medicamentos de uso domiciliar apenas no que tange a quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento de câncer (inciso IX), bem como medicamentos antineoplásicos orais, como dispõe o inciso X, ambos do art. 18, da RN em relevo.

Ressalte-se que no julgamento dos REsp 1.692.938/SP e 1.883.654/SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), especificamente tratando da obrigação de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, como no caso dos autos, reconheceu ser "*lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim*", sendo esta, conforme explanado pelos julgadores, a melhor interpretação dos arts. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, inc. VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, inc. VI, da RN nº 465/2021).

Nesse sentido, seguem ainda recentes julgados do **STJ** e dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais (**TJMG**) e do Rio de Janeiro (**TJRJ**):

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. **COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR** NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. **CANABIDIOL** PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998.1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023 .2. **O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998** .3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o

que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF) .4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF) .5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI edo § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal .6. **A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998** .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (**STJ** - REsp: 2071955 RS 2023/0151582-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe **07/03/2024**)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - MENOR - TRÂMITE NA VARA CÍVEL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PLANO DE SAÚDE - **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - CANABIDIOL - EXCLUSÃO CONTRATUAL** - RESP N. 1.692.938/SP - EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. (...) 3. **Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados**, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. V.v. (**TJ-MG** - AC: 50161444520218130145, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: **20/04/2023**)

Direito do consumidor. **Plano de saúde. Requerimento de tutela antecipada para fornecimento de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol**. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Agravo de instrumento. **Legitimidade da exclusão de cobertura consistente em fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvados os antineoplásicos. Precedentes do STJ. A operadora do plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos à base de canabidiol para uso domiciliar. Falta de probabilidade da existência do direito material**. Desprovimento do recurso. (**TJ-RJ** - AI: 00588801420228190000 202200280992, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 13/02/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: **14/02/2023**).

É de se destacar, ainda, em conclusão, que os precedentes em que o STJ e demais tribunais tem entendido pela obrigatoriedade de fornecimento de medicamento pelo plano de saúde para uso domiciliar pelos consumidores, referem-se a circunstâncias

diversas dos autos, como, por exemplo, **para tratamento de neoplasias malignas ou de doenças graves e crônicas** (a este respeito: AgInt no AREsp 918635; REsp 1641135/SP e AgRg no REsp 1541966/RS).

Ademais, a operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamentos importados não nacionalizados, consoante o art. 10, V, da Lei 9.656/98. Norma esta que foi considerada válida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do **Tema 990 de Recursos Repetitivos**, em que se firmou a seguinte tese: "*As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA*."

Já no tocante à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.165.959, **Tema 1161 de Repercussão Geral**, é também necessária a distinção para o caso concreto. A tese assim dispõe:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

A hipótese dos autos não é voltada contra o Estado, o qual, por ordem constitucional, tem um dever de prestação de serviços de saúde muito mais amplo, com garantia de acesso universal e igualitário (art. 196, CRFB/88). Lógica que não se aplica aos planos de saúde, inseridos na seara da saúde suplementar.

Assim, não cabe atribuir às operadoras de planos de saúde a mesma obrigação que se atribui ao Estado. Notadamente, no caso de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, enquanto a lei prevê a exclusão de cobertura pelos planos de saúde, possui o Estado, atrelada ao Sistema Único de Saúde, uma Política Nacional de Medicamentos, para garantir à população de baixa renda o acesso aos fármacos necessários à manutenção de sua saúde.

Deste modo, não tendo o plano de saúde a obrigação de fornecer o medicamento vindicado, não há como acolher o pedido de obrigação de fazer. Por via de consequência, inexiste dano moral.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos, ao tempo que **extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.**

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em sintonia com o art. 85, § 2º do CPC/15. (custas já recolhidas)

Dê-se ciência do Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

P.R.I.

Recife, 26 de maio de 2025

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
26/05/2025 10:50:42
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 205165576

25052610504267100000199833883

IMPRIMIR GERAR PDF